

TEMA 3.47 • OBSTETRICIA

Detección de Hipoxia Fetal Anteparto

PERFIL EUNACOM 1.03.47

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Detección de Hipoxia Fetal Anteparto

Exámenes Disponibles

| TABLA 3.47.1: EXAMEN VS INDICACIÓN |                                 |              |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| EXAMEN                             | INDICACIÓN                      | MOMENTO      |
| RBNE                               | 1ª línea (screening)            | Cualquier EG |
| PBF                                | Confirmatorio                   | Cualquier EG |
| TTC                                | El más sensible (confirmatorio) | ≥ 36 semanas |

1. Registro Basal No Estresante (RBNE)

Examen de primera línea ante sospecha de hipoxia anteparto (ej.: disminución de movimientos fetales).

Basal = en reposo, sin contracciones uterinas.

Dura 20 minutos inicialmente.

Interpretación

| TABLA 3.47.2: RESULTADO VS CRITERIO |                             |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| RESULTADO                           | CRITERIO                    | CONDUCTA             |
| Reactivo                            | ≥ 2 aceleraciones en 20 min | Observar (feto bien) |
| No reactivo                         | < 2 aceleraciones en 20 min | Alargar 20 min más   |

Si sigue no reactivo (total 40 min): confirmar con PBF o TTC.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No reactivo ≠ ominoso. Es solo screening. Si está alterado, confirmar con otro examen antes de actuar.

2. Perfil Biofísico (PBF)

Examen confirmatorio. Usa ecografía + RBNE.

Componentes y Puntaje (máximo 10 puntos)

| TABLA 3.47.3: VARIABLE VS PUNTAJE MÁXIMO |                |
|------------------------------------------|----------------|
| VARIABLE                                 | PUNTAJE MÁXIMO |
| Movimientos fetales                      | 2 pts          |
| Movimientos respiratorios fetales        | 2 pts          |
| Tono fetal (postura flexora)             | 2 pts          |
| Líquido amniótico                        | 2 pts          |
| RBNE                                     | 2 pts          |
| Total                                    | 10 pts         |

NOTA CLÍNICA

El líquido amniótico es la variable más importante para tomar decisiones cuando el puntaje es límite.

Interpretación

| TABLA 3.47.4: PUNTAJE VS CLASIFICACIÓN |                |                                     |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| PUNTAJE                                | CLASIFICACIÓN  | CONDUCTA                            |
| ≥ 8 / 10                               | Tranquilizador | Observar                            |
| 6 / 10                                 | Indeterminado  | Decidir según líquido amniótico     |
| ≤ 4 / 10                               | Ominoso        | Interrumpir por la vía más expedita |

Puntaje 6/10 → Decisión por Líquido Amniótico

| TABLA 3.47.5: LÍQUIDO AMNIÓTICO VS CONDUCTA |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| LÍQUIDO AMNIÓTICO                           | CONDUCTA                            |
| Normal (2/2)                                | Observar                            |
| Oligoamnios (0/2)                           | Interrumpir por la vía más expedita |

3. Test de Tolerancia a las Contracciones (TTC)

El mejor examen (mayor sensibilidad), pero con la limitación de requerir EG ≥ 36 semanas.

- Se administra goteo oxitócico para inducir contracciones artificialmente
- Se registra la FCF en relación a esas contracciones
- Interpretación: idéntica al MEFI (mismas categorías, mismos criterios)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Contraindicado < 36 semanas: riesgo de desencadenar parto prematuro. En embarazos más precoces, usar PBF.

Resumen Comparativo

| TABLA 3.47.6: EXAMEN VS PRIMERA / CONFIRMATORIA |                         |                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| EXAMEN                                          | PRIMERA / CONFIRMATORIA | CONTRACCIONES   | LIMITACIÓN        |
| RBNE                                            | 1ª línea                | No (basal)      | Solo screening    |
| PBF                                             | Confirmatoria           | No (eco + RBNE) | Requiere ecógrafo |

| TTC | La más sensible | Sí (oxitocina) | Solo ≥ 36 sem |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Detección de Hipoxia Fetal Anteparto: RBNE | 1ª línea (screening) | Cualquier EG | | PBF | Confirmatorio | Cualquier E... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Detección de Hipoxia Fetal Anteparto. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Exámenes Disponibles
- 1. Registro Basal No Estresante (RBNE)
- Interpretación
- 2. Perfil Biofísico (PBF)
- Componentes y Puntaje (máximo 10 puntos)
- Puntaje 6/10 → Decisión por Líquido Amniótico
- 3. Test de Tolerancia a las Contracciones (TTC)

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DETECCIÓN DE HIPOXIA FETAL ANTEPARTO)****PREGUNTA 1**

En relación a Detección de Hipoxia Fetal Anteparto: RBNE | 1ª línea (screening) | Cualquier EG | | PBF | Confirmatorio | Cualquier E... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Detección de Hipoxia Fetal Anteparto se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Detección de Hipoxia Fetal Anteparto debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Detección de Hipoxia Fetal Anteparto requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Detección de Hipoxia Fetal Anteparto es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Detección de Hipoxia Fetal Anteparto no es necesario una vez iniciado el tratamiento

**PREGUNTA 2**

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Detección de Hipoxia Fetal Anteparto?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

**PREGUNTA 3**

Paciente consulta con cuadro compatible con Detección de Hipoxia Fetal Anteparto. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

**RESUMEN: DETECCIÓN DE HIPOXIA FETAL ANTEPARTO**

Examen de primera línea ante sospecha de hipoxia anteparto (ej.: disminución de movimientos fetales). :::warning No reactivo ≠ ominoso. Es solo screening. Si está alterado, confirmar con otro examen antes de actuar. ::: :::note El líquido amniótico es la variable más importante para tomar decisiones cuando el puntaje es limítrofe. :::